

PROTOKOLL:

«Helserelatert livskvalitet og erfaringar frå sjukehusopphaldet»

¹Ranveig Boge, sjukepleiar/cand.san, ¹Ragna Lind, sjukepleiar/ph.d.,

^{2,3}Stig Harthug, dr. med./professor II

¹Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

²Seksjon for pasientsikkerheit, FoU-avdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

³Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, Norge

Bakgrunn

Forsking, også i Norge, syner at det er ei samanheng mellom tilhøve ved sjukehus, lengd av opphald og re-innlegging (1). Kvar femte eldre pasient vert re-innlagt innan 28 dagar etter utskriving, og for nye brukarar av omsorgstenester, blir kvar tredje pasient re-innlagt (2). Re-innlegging av eldre og pasienterfaringar med somatiske sjukehus er to nye kvalitetsindikatorar publisert av Helsedirektoratet (3). Ei undersøking gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta i 2011 viste at pasientane har gode erfaringar med sjukehusa på mange område, men at det er stort forbettringspotensiale mellom anna når det gjeld indikatorane «forberedelse av pasientene til tida etter utskriving» og «samhandling med andre helsetjenester» (4). Danielsen og Fjær (5) meiner samhandlinga bør bygge på gjensidig respekt og tillit, med utvikling av eit meir forpliktande og gjensidig samarbeid til beste for pasienten.

Samhandlingsreforma (6) blei innført i Norge 1. januar 2012. Planlegging og innføringa av denne reforma har i stor grad handla om formalisering av overføringa av pasientar mellom dei to nivå, og det er behov for forsking når det gjeld korleis kvalitet og sikkerheit skal bli ivarettatt ved overgangen mellom tenestenivåa. Frå Norge har vi mangelfull forskingsbasert kunnskap om desse utfordringane (7).

Denne studien er første del av eit større forskingsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus kor ein vil undersøke samanhengen mellom pasienterfaringar og kvalitet i omsorgstenesta, samt få eit betre kunnskapsgrunnlag for å kunne forbetre praksis. I studien som ligg føre er formålet å få kunnskap om korleis pasientar som vert skrivne ut frå sjukehus vurderer si eiga helse, kva erfaringar dei har med sjukehusopphaldet, samt helseplager og problem etter utskriving. Vi ynskjer også å kartlegge kva type omsorgstenester pasientane får, og kor dei oppheld seg i dei første 30 dagar etter utskriving, samt undersøke re-innlegging i sjukehus i dette tidsrommet.

Materiale og metode

Kriteria for inklusjon:

- Kvinner og menn ≥ 65 år
- Behov for omsorgsteneste etter utskriving frå sjukehus
- Liggetid > 24 timer i sjukehus
- Kan gje fritt informert samtykke
- Har ikkje fast plass i sjukeheim
- Snakkar norsk
- Er i stand til å fylle ut spørreskjema utan hjelp

Utval:

Inklusjon av inntil 400 pasientar innlagt ved tre medisinske og tre kirurgiske postar ved Haukeland universitetssjukehus. Styrkeberekning viser det er nødvendig med data frå over 200 pasientar for å kunne gje pålitelege svar på forskningsspørsmåla. Svarprosent på 50 % vil sikre dette.

Spørjeskjema:

Short Form-12 (SF12)

Helserelatert livskvalitet: 12 spørsmål inndelt i to underkategoriar (fysisk helse og mental helse). Svaralternativ ja/nei eller svaralternativ med gradering på ein 3, 5 eller 6 - punkt skala. Kvar skala vert transformert til ein 0 til 100 skala (8).

2. The Nordic Patient Experiences Questionnaire (NORPEQ)

Pasienterfaringar i somatiske sjukehus: 8 spørsmål omkring erfaring med kommunikasjon, tillit til helsepersonell, pleie og behandling, og evt. feilbehandling. Gradering på ein 5 - punkt skala med svaralternativ frå «ikke i det hele tatt» til « i svært stor grad». Skjemaet er validert på norsk 9, 10).

3. Spørsmål om problemer etter utskrivelse fra sykehus

10 spørsmål om problemer med instruksjoner gitt i sykehuset og etterlevelse av disse, problemer med å kjøpe og å ta medisiner, og problemer med daglige aktiviteter, sosial støtte og ernæring. Svaralternativene er gradert fra «1 = ja», «2 = delvis», «3 = nei», «4 = ikke aktuelt».

4. Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS)

MUIS (11) inneholder 5 påstander som; jeg har mange spørsmål uten svar, jeg forstår alt som blir forklart til meg, legene sier ting til meg som kan ha ulike betydninger, det er så mange forskjellige yrkesgrupper, det er uklart om hvem som har ansvar for hva og formålet med hver behandling er klart for meg. Påstandene graderes fra «1 = helt uenig», «2 = uenig», «3 = usikker», «4 = enig» og «5 = helt enig». Skalaen har vært brukt i studier hos kvinner behandlet for brystkreft og hos menn behandlet for prostatakreft (12, 13).

5. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

Spørreskjemaet består av 14 spørsmål hvor av 7 kartlegger angst og 7 depresjon. Hvert spørsmål har en skår fra 0 = *ikke i det hele tatt* til 3 = *veldig ofte*. Skjemaet er validert, og angst er definert ved en cut-off verdi HADS-A ≥ 8 og depresjon HADS-D ≥ 8 (14, 15).

6. Fatigue Severity Scale (FSS)

FSS (16) består av 9 påstander som kartlegger effekten av tretthet/utmattelse på psykososiale og fysiske daglige funksjoner. Den er gradert fra 1 til 7, der 1 betyr » *helt uenig med påstanden*» og 7 betyr *«helt enig med påstanden»* I tillegg blir det brukt en visuell analog skala (VAS) som er en horisontal 100 mm linje der beskrivelsen på venstre ende (0 mm) er «ingen problemer med tretthet og utmattelse» og på høyre side (100 mm) «så mye tretthet og utmattelse som det er mulig å ha» (17). FSS er validert både i den generelle befolkningen (18), og hos personer i forskjellige sykdomsgrupper (19). Når Lerdal og medarbeidere testet de psykometriske egenskapene i den norske oversettelsen av skalaen (20), konkluderte de med at terskelen for å definere tilfeller av tretthet/utmattelse bør være en FSS score på 5 eller høyere fordi dette er mer i samsvar med resultater fra tidligere funn av tretthet/utmattelse i den generelle norske befolkningen (19, 20).

7. Subjective Health Complaints (SHC)

Subjektive helseplager (29 spørsmål) kartlegger subjektive, somatiske og psykososiale plager i løpet av de siste 30 dager (21). Spørreskjemaet er testet i forskjellige befolkninger, og har tilfredsstillende validitet og reliabilitet (22). Graden av plagene er gradert fra «0 = ikke plaget», «1 = litt plaget», «2 = en del plaget og «3 = alvorlig plaget. Skjemaet er delt inn i 5 undergrupper; smerte (hodepine, migrene, nakkesmerter, smerter i armer, skuldersmerte, øvre ryggsmerte, smerter i korsrygg, leggsmerter), pseudonevrologi (tretthet, søvnproblemer, angst, depresjon, hjertebank, hetetokter, svimmelhet), gastrointestinale problemer (sure oppstøt- «halsbrann», sug eller svie i magen, magekatarr, magesår, mageknip, ”luftplager” løs avføring, diaré, forstoppelse), allergi (allergi, pusteproblemer, eksem, astma) og influensa (forkjølelse/influensa, hoste/bronkitt).

Opplysninger henta frå pasientadministrativt system (DIPS)

Lengd på siste sjukehusopphald, avdeling/post, utskrivingsdiagnoser, tal på innleggingar siste 12 månader og telefonnummer.

Framgangsmåte

Pasientane vil få munnleg og skriftelig informasjon før førespurnad om å delta i studien. Datainnsamlinga vil gå føre seg i tidsrommet mai-desember 2013. Undersøkinga blir gjennomført ved bruk av spørreskjema i sjukehus (baseline 69 spørsmål, skjema nr. 1, 4, 5, 6 og 7) og 1 (ein) månad etter utskriving frå sjukehuset (94 spørsmål, alle skjema). Spørreskjema blir sendt i frankert konvolutt til pasientane 27-30 dagar etter utskriving. Data blir plotta og lagra på godkjent forskingsområde i Helse Bergen. Pasientane blir spurt om telefonnummer slik at vi kan eventuelt kan ringe og minne om undersøkinga om vi ikkje mottek svar.

Etiske aspekt

Studien blir utført i samsvar med Helsinkideklarasjonen. Det vil bli innhenta samtykke-erklæring frå alle deltakarane før utskriving frå sjukehuset.

Publisering

Resultat vil bli presentert i internasjonalt tidsskrift med fagfelleevaluering.

Referansar

1. Heggstad T. Do hospital length of stay and staffing ratio affect elderly patients' risk of readmission? A nation-wide study of Norwegian hospitals. Health Serv Res. 2002 Jun;37(3):647-65.
2. Helse og omsorgsdepartementet (2012). Reinnleggelser av eldre. Tilgjengelig frå: <http://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Reinnleggelser-av-eldre.aspx> [Lasta ned 15.2.2013]
3. Helse og omsorgsdepartementet (2012) Pasienterfaringer med somatiske sykehus 2011. Tilgjengelig frå: <http://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Pasienterfaringer-med-somatiske-sykehus-i-2011.aspx> [Lasta ned 15.2.2013]

4. Skudal KE, Garratt .G, Eriksson B, Leinonen T, Simonsen J & Bjertnæs ØA. The Nordic Patient Experiences Questionnaire (NORPEQ): cross-national comparison of data quality, internal consistency and validity in four Nordic countries. *BMJ Open* 2012;2. doi: 10.1136/bmjopen-2012-000864.
5. Danielsen B. & Fjær S. Erfaringer med å overføre syke eldre pasienter fra sykehus til kommune, *Sykepleien Forskning* 2010;5:36-4.
6. Helse og omsorgsdepartementet (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. St.meld. nr. 47. Tilgengelig frå:
<http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-html?showdetailedtableofcontents=true&id=567201> [Lasta ned 14.10.2012]
7. Foss C, Hoffoss D, Romøren, TO, Bragstad LK, Kirkevold M. Eldres erfaringer med utskriving fra sykehus, *Sykepleien Forsking* 2012;7:324-333.
8. Ware JE Jr, Sherbourne CD, The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). Conceptual framework and item selection. *Med Care* 1992;6:473-83.
9. Oltedal, S., Garratt,A., Bjertnæs, Ø., Bjørnsdottir, M., Freil M. & Sachs M. The NORPEQ patient experiences questionnaire: Data quality, internal consistency and validity following a Norwegian inpatient survey. *Scand J Public Health* 2007; 35: 540.
10. Mishel MH. The measurement of uncertainty in illness. *Nurs Res* 1981;30:258-263.
11. Mishel MH, Germino BB, Gil KM, Belyea M, Laney IC, Stewart J, Porter L, Clayton M. Benefits from an uncertainty management intervention for African-American and Caucasian older long-term breast cancer survivors. *Psycho-Oncology* 2005;14:962-978.
12. Mishel MH, Germino BB, Belyea M, Stewart JL, Bailey DE, Mohler J, Robertson C. Moderators of an uncertainty management intervention: For Men with Localized Prostate Cancer. *Nurs Res* 2003;52:98-97.
13. Mishel MH, Germino BB, Gil KM, Belyea M, Laney IC, Stewart J, Porter L, Clayton M. Benefits from an uncertainty management intervention for African-American and Caucasian older long-term breast cancer survivors. *Psycho-Oncology* 2005;14:962-978.
14. Herrmann C. International experiences with the Hospital Anxiety and Depression Scale – a review of validation data and clinical results. *J Psychosom Res* 1997;42:17-41.
15. Mykletun A, Stordal E, Dahl AA. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): Factor structure, item analysis, and internal consistency in a large population. *Br J Psychiatry* 2001;178:504-544.
16. Krupp LB, LaRocca NG, Muir-Nash J *et al.* The fatigue severity scale. Application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. *Arch Neurol* 1989;46:1121-1123.

17. Harboe E, Tjensvoll AB, HK Vefring, Gøransson LG, Kvaløy JT, Omdal R. Fatigue in primary Sjögren's syndrome – A link to sickness behaviour in animals? *Brain Behav Immun* 2009;23:1104-1108.
18. Lerdal A, Wahl AK, Rustøen T, Hanestad BR, Moum T. Fatigue in the general population: A translation and test of the psychometric properties of the Norwegian version of the fatigue severity scale. *Scan J Pub Health* 2005;33:123-130.
19. Lerdal A, Kottorp A. Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale - Rasch analyses of individual responses in a Norwegian stroke cohort. *Int J Nurs Studies* 2011;48:1258-65.
20. Loge JH, Ekeberg O, Kaasa S. Fatigue in the general Norwegian population: normative data and associations. *J Psychosom Res* 1998;45:53-65.
21. Eriksen HR, Ihlebæk C, Ursin H: A scoring system for subjective health complaints. *Scand J Public Health* 1:63–72, 1999.
22. Wilhelmsen I, Mulindi S, Sankok D, Wilhelmsen AB, Eriksen HR, Ursin H. Subjective health complaints are more prevalent in Maasais than in Norwegians. *Nord J Psychiatry* 2007;4:304–309.